

05 - 05- Cancers de la vulve - Pr. Soummani

Les cancers de la vulve, c'est quoi ? C'est un cancer, c'est tout type de cancer qui se développe au niveau des éléments anatomiques de la vulve. La vulve, c'est la grande lèvre, la petite lèvre, le clitoris et les glandes de Bartholin. C'est ça l'anatomie de la vulve.

Tout tumeur de cette origine est un cancer de la vulve. C'est une prolifération maligne qui touche les éléments constitutifs de la vulve. Il est peu fréquent, 5 % des cancers géniques aux mammaires.

Il doit être dépisté précocement, mais malheureusement, une femme, parce que c'est un cancer également de la femme âgée, la femme âgée a du mal à aller chez le gynécologue. En général, c'est une zone, elle a du mal à dire à ses enfants qu'elle a une lésion au niveau de la vulve. Même ses filles, par exemple.

Donc, s'il est dépisté tôt, le pronostic est extrêmement bien. Il est rarement métastatique, c'est un cancer loco-régional. Le problème, c'est qu'il survient chez la femme âgée, ce qui fait le retard du diagnostic.

On le diagnose qu'à un stade avancé et par conséquent, le pronostic devient moins bon. 5 %, c'est la femme âgée, 65 à 75 ans. 35 % des cancers de la vulve surviennent après 70 ans.

Vous voyez, c'est exclusivement, pratiquement exclusivement la femme âgée. Mais selon mon expérience personnelle, on a tendance à avoir une augmentation des formes de la femme jeune. J'ai opéré une femme qui avait 34 ans qui avait un cancer de la vulve.

En général, on va voir que c'est comme la même chose que le carcinome épidermique du col de l'utérus, c'est l'HPV. Donc, c'est la même chose. Plus on a une augmentation de l'activité sexuelle, augmentation de l'infection HPV, plus on aura plus de cancers chez la femme jeune.

Donc, c'est le virus herpétique H. Le type 2, lorsqu'on fait une biopsie pour cancer du col, on trouve l'herpès virus dans 32 % des biopsies. Mais c'est surtout le papillomavirus, surtout les sérotypes 16 et 18. Ce sont les sérotypes qui sont les plus oncogènes.

Donc, voilà les points communs entre les trois sites. Les trois sites de cancer, c'est-à-dire les points communs au niveau de la vulve. C'est-à-dire la vulve, les trois sites, la vulve, le vagin et le col de l'utérus.

Donc, les trois sites de cancer, le plus souvent, c'est le virus HPV, le papillomavirus. Deuxièmement, c'est le carcinome épidermoïde comme type de description. C'est le plus fréquent.

Et quatrièmement, ce n'est pas comme le cancer du sein. Mais dans le cancer de ces trois sites, col, vagin, vulve, il y a un continuum lésionnel. Infection HPV, dysplasie bas-grade, dysplasie

haut-grade, carcinome in situ, carcinome micro-invasif, carcinome invasif.

C'est un continuum lésionnel. Donc, plus tu fais le diagnostic précocement, plus tu as l'avantage d'être moins agressif sur le plan thérapeutique et d'être plus efficace parce que tu vas traiter correctement la patte. Au stade de dysplasie haut-grade, du col de l'utérus par exemple, le traitement entraîne une guérison à 100%.

Par contre, si vous êtes à un stade de A, vous avez une survie, on ne parle plus de guérison, on parle de survie de 60%. Donc, c'est toujours une progression de la néoplasie intra-épithéliale jusqu'au cancer invasif. Est-ce que vous avez fait comme ça pour le cancer du col ? Ces trois sites, la similitude entre les trois sites, col, vagin, vulve.

Au moment où il y a une lésion au niveau du vagin, il faut obligatoirement explorer le vagin et le col de l'utérus parce que tu peux avoir une atteinte au niveau de tout le tractus. Voilà, l'HPV, qu'est-ce qu'il entraîne sur le plan épidémiologique ? C'est des condylomes accumulés, mais c'est surtout le HPV 6 et 11. Je trouve que dans 80% des cas, le condylome plan, c'est énorme.

Le condylome accumulé et la différence entre le condylome accumulé et le condylome plan. Le condylome accumulé, c'est en général le papillomavirus sérotype 6 et 11. En général, plus souvent, il n'évolue pas vers le cancer.

Par contre, le condylome plan, c'est en général dû au sérotype 16 et 18. C'est le même sérotype qui entraîne le cancer de la vulve. Donc, il y a le risque de transformation cancéreuse.

C'est long, mais c'est ce que je vous ai dit. Elle passe par la dysplasie, etc., jusqu'au cancer. Donc, c'est là où vous devez agir.

C'est au début, pas à la fin, pas au stade de cancer invasif, mais au début pour chercher les lésions pré-invasives, pré-cancéreuses. C'est les dysplasies. Les dysplasies, ça peut être au niveau de la vulve, au niveau du vagin, au niveau du col.

Donc, voilà un peu pourquoi. Donc, voilà, vulve, vagin et col. Tumeurs malignes, les plus fréquentes, c'est le carcinome épidermoïde.

Donc, plus de 80% des cas au niveau de cet oocyte, c'est l'épidermoïde. Il y a les adénocarcinomes, c'est surtout au niveau de la glande du bartholin. Et il y a les mélanomes.

Les mélanomes, en général, vous connaissez les mélanomes, comme le hala qui se transforme en cancer. C'est grave, le mélanome est grave. Bon, les myoplasies intra-épithéliales, je ne vais pas vous parler de ça, c'est trop compliqué.

Je suis sûr que vous n'allez pas... Bon, lisez si vous voulez, mais à part la maladie de Bowen, qui est vulvaire, qui est la pathologie Keim, la maladie de Pagé. La maladie de Pagé, c'est une petite lésion rougeâtre avec prurites. Et en général, il n'y a rien au niveau de la peau.

Mais au niveau de la sous-cutanée, où il y a la lésion invasive. Ça, c'est un problème. Mais reprenez surtout ça, la maladie de Bowen, vulvaire.

Parce que c'est important en dermatologie. Le plus souvent, c'est les dermatologues qui nous envoient ce type de... Lorsque la maladie est survenue avant le cancer. On le voit beaucoup plus que le cancer.

Soit on le voit seul, soit on le voit parce que le dermatologue a fait le diagnostic d'une lésion précancéreuse pour traitement chirurgical. Donc, si vous avez fait ça, ce n'est pas la peine. Voilà quelques lésions.

Donc, on va parler du cancer invasif macroscopiquement. C'est une lésion, soit une lésion exophytique, soit une lésion endophytique. Exophytique, c'est un bourgeon.

Endophytique, c'est une ulcération, tout simplement. Les deux sont des cancers. Donc, moralité, chaque fois que vous avez une lésion au niveau de la vulve, vous devez faire une biopsie, tout simplement.

Elle est visible. Et surtout, si c'est une lésion qui survient chez un lapin ménopausé, asie. Le type histologique le plus fréquent, c'est le carcinome épidermoïde, le carcinome spinocellulaire, le mélanome, le sarcome, le carcinome basocellulaire, basocellulaire ou au-delà de la glande.

Mais le basocellulaire est moins fréquent. La maladie de Pagé et l'adénocarcinome des glandes de Bartholin. Voilà la glande de Bartholin, parce que c'est important.

Donc, le plus fréquent, c'est le carcinome épidermoïde, le spinocellulaire. Le mélanome, il est moins fréquent, mais il est plus grave, et les cancers de l'adénocarcinome de la glande de Bartholin. Voilà, c'est une lésion endophytique, c'est une ulcération.

Donc, l'étude clinique, mais c'est fonctionnel. Le premier symptôme, c'est le prurite. Le cancer de la vulve, c'est une maladie prurigineuse.

Plus souvent, dans 30 à 70 % des cas, c'est un prurite vulvaire. En général, il se revient chez une femme âgée, c'est un prurite qui peut empêcher le sommeil, tellement il est important qu'il peut empêcher le sommeil. Ça peut être une douleur, une brûlure, ou bien la femme qui va trouver la tumeur.

Donc, la tumeur. Et gynécologue femme, tout simplement, parce que même son mari, parfois, ça fait... Donc, vous voyez, ça a changé pour maintenant, mais vous aurez des femmes de 80 ans, 85 ans, qui viennent consulter pour la première fois. Donc, elle ne veut même pas parler à ses filles de sa lésion vulvaire.

Donc, c'est ça qui fait que le diagnostic est tardif. Mais en général, il devrait être précoce, mais non. Donc, l'examen physique, vous allez voir la lésion bourgeonnante ou l'ulcération.

Vous allez faire une palpation pour voir s'il y a une infiltration, parce que le cancer, c'est connu par son infiltration. Vous allez trouver comme des rameaux qui vont en profondeur. Ça fait la différence entre le cancer et une lésion bénite.

Lésion bénite n'est pas infiltrant, mais le cancer est infiltrant. Vous allez voir s'il y a une atteinte du vagin et s'il y a une atteinte anale. Et vous allez mettre votre spéculum, si vous pouvez le faire, parce que d'abord, la tumeur empêche.

Deuxièmement, l'atrophie vaginale empêche. Et troisièmement, parce que la femme a des douleurs, elle a une atrophie vaginale. Donc, touchez rectal, touchez vaginale, touchez rectal pour voir s'il y a... une atteinte du col.

Et vous allez faire, bien sûr, ce qui est important, c'est l'examen somatique pour voir l'état général de la femme. Est-ce qu'elle n'a pas d'autres lésions ? Donc, les formes cliniques. Il y a la forme clitoridienne.

C'est une forme qui est très, très, très, très douloureuse. C'est le clitoris qui est atteint. En général, elle survient.

Il y a le clitoris, il y a l'urètre, donc c'est à côté. Donc, dès qu'il y a l'atteinte, même à un stade précoce, l'urètre peut être envahi. C'est important.

Et deuxièmement, elle est très douloureuse, très prurigineuse, et il donne automatiquement... Elle entraîne un envahissement bilatéral au niveau des extensions lymphatiques. Deuxième forme clinique, c'est la forme... Deuxième forme en fonction de la localisation, c'est les glandes de Bartholin. En général, je vous ai dit que c'est un adénocarcinome.

C'est des glandes, donc c'est un adénocarcinome. Celui-là, elle peut survenir chez la femme jeune. Le cancer de la glande de Bartholin peut survenir chez la femme jeune et elle a un aspect inflammatoire.

C'est comme une infection. C'est comme une Bartholinite. Les formes cliniques, je vous ai dit qu'il y a de plus en plus une augmentation de la fréquence de cancer chez la femme jeune avant la ménopause, même avant 40 ans.

Ce qui fait, vous voyez que si vous faites une bulle vectomie à une femme jeune à 34-35 ans, sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan familial, il y a une atteinte de tout ça. Ceci d'une part, et d'autre part, si vous avez un cancer de la bulle, chez une femme jeune, obligatoirement, il faut explorer, pas voir, explorer le col de l'utérus. Parce qu'il y a beaucoup d'associations, cancer du col, cancer de la bulle.

Il y a la forme clinique de la femme, de la fille, l'enfant. C'est le sarcome, le sarcome de la vulve. Ça revient chez la femme, la fille de 14 ans, 13 ans, etc.

C'est surtout le sarcome botryoïde. Celui-là, il se manifeste comme une tumeur bénigne. Mais en général, une tumeur, on fait la résection, on est obligé d'envoyer chez l'anapath qui va parler du sarcome.

Donc les formes, la femme jeune, c'est une évolution rapide. En général, beaucoup de problèmes. En général, il faut éliminer un cancer du col de l'utérus.

Et la femme et la fille, c'est surtout le sarcome. Donc le traitement, c'est simple. Le traitement, vous avez une lésion.

Soit vous allez prendre une lame et vous allez la mettre au contact de la lésion pour voir est-ce qu'il y a des cellules cancéreuses. Mais c'est surtout, vous prenez une lame de bistouri et vous faites une biopsie. Et attention, il saigne.

Si vous faites la biopsie, faites des points profonds pour arrêter le saignement. Et vous aurez le diagnostic, tout simplement. C'est pas plus simple que le cancer de la boue.

On le voit. Le bilan d'extension, actuellement on fait la TDM abdominopelvienne. Avant, on faisait la rectoscopie, on faisait l'assistoscopie, etc.

Mais actuellement, la TDM abdominopelvienne permet de voir est-ce qu'il y a un envahissement sur tous les ovaires, sur tous les ganglions. Le plus souvent, il n'y a que des atteintes ganglionnaires. Au niveau inguinal, unilatéral, mais ils peuvent aller vers les ganglions pelviens.

Donc, c'est pour ça que le traitement est différent en fonction des opérateurs. Est-ce qu'il faut faire une vulvectomie totale avec curage inguinal, profond, superficiel, et le curage pelvien ou non ? Donc, voilà les stades A et B. Moins de 2 cm, plus de 2 cm. Et regardez les adénopathies.

Invasion du tiers inférieur du vagin, ou le tiers inférieur de l'urètre. Pourquoi le tiers inférieur de l'urètre ? Parce qu'au niveau du tiers inférieur de l'urètre, on a un sphactère. Même si tu résèques l'urètre à 2-3 cm, tu peux ne pas avoir une incontinence urinaire.

Par contre, au-delà, il y a une incontinence urinaire. Donc, le stade 3, le vagin ou l'anus. Bon.

Donc, je ne vais pas poser de questions sur ça. Pour la simple raison que ça change avant. Actuellement, peut-être que chaque 2 ans, vous aurez une classification.

Ce que vous devez avoir, c'est que je parle lorsque vous allez être actif, vous allez travailler. C'est, mettez un classeur où vous allez mettre vos classifications. C'est bête de demander à un étudiant une classification de l'endomètre, oui, de l'ovaire, oui, du sein, oui, du col, oui, mais de la vulve.

D'abord, c'est 5% de tous les cancers. Vous aurez peu de chances de voir un cancer de la vulve. Pourquoi apprenez une classification qui va peut-être changer d'ici 2 ans.

Donc, le traitement chirurgical. Bon, le traitement idéal, c'est une vulve. Je parle de cancers invasifs.

Je ne parle pas de cancers pré-invasifs, avant l'invasion. Avant l'invasion, on doit être conservateur. On ne peut enlever que la lésion, on ne peut enlever que la moitié de la vulve.

On ne peut enlever qu'une vulve et on laisse l'autre. On peut faire une vulve vectomée partielle. Mais je parle ici de cancers invasifs de la vulve.

C'est une vulve vectomée totale avec curage ganglionnaire, inguinaux, curage. C'est-à-dire inguinaux superficiel et profond. Profond, c'est sous la ponevrose inguinale.

La ponevrose, on passe ce qu'on appelle le facièrè cribri-formis. C'est-à-dire de l'interne. Vous allez étudier l'anatomie du scarpa.

Parce qu'il y en a plein d'anatomies. Bon, qu'est-ce que je vais poser ? Le creux axillaire, l'urtere pelvien chez la pomme, les rapports anatomiques de l'isthme utérin, ou bien le triangle de scarpa. Ne pensez pas que seul le traumatologue peut poser cette question parce que nous opérons le scarpa plus que le traumatologue.

Peut-être le creux poplite. Moi, je ne vais pas poser une question sur le creux poplite. Mais je peux poser une question sur le triangle du scarpa.

Donc faites attention, pour ceux qui préparent l'interne à nous. Donc, vulvectomie totale avec urage ganglionnaire, unie ou bilatérale ? Ça, ça se discute. Vulvectomie partielle pour les lésions non-invasives.

Tumorectomie pour les lésions non-invasives. La radiothérapie, curiothérapie ou radiothérapie externe, le plus souvent c'est de la radiothérapie externe. La chimiothérapie, c'est en général comme le cancer du col de l'utérus, ce n'est pas le col de l'utérus.

Quelle chimiothérapie vous utilisez ? C'est à base de 6 platines. Soit le carboplatine, soit le 6-platinum. Je vous ai déjà parlé de ça.

Je vous ai déjà parlé de ça, mais je n'y reviendrai pas. Je vous avais dit de le voir juste après. Je ne vais pas vous en parler.

Donc, la curiothérapie, radiothérapie, chimiothérapie, à base de 6 platines ou le carboplatine. La différence entre les deux, les deux sont efficaces, mais le 6-platine est plus néfrotoxique que le carboplatine. Mais malheureusement, le 6-platine est beaucoup, beaucoup moins cher que le carboplatine.

Bon, c'est toujours. Le traitement au laser également, on peut détruire les lésions, mais je parle des lésions précancéreuses. Le cancer invasif, le cancer invasif, c'est une vulvectomie totale

avec un curage ganglionnaire.

Après, l'anapathie. Si vous êtes en zone saine, s'il n'y a plus de cancer, c'est-à-dire que vous allez passer en zone saine, il n'y a pas d'envahissement ganglionnaire, votre traitement est efficace, et la pomme est pratiquement guérie, pratiquement parce qu'il y a les récidives, malheureusement. Si l'anapathie vous dit que la résection n'est pas en zone saine ou bien il y a un envahissement massif de ganglions, dans ce cas, vous pouvez ajouter de la radiothérapie.

En général, c'est de la radiothérapie externe. Pour les cancers intraépithéliaux ou les lésions précancéreuses, dans ce cas, c'est une chirurgie partielle conservatrice soit vulvectomie partielle, soit tumorectomie, soit un traitement par la radiothérapie, soit on peut détruire les lésions par le laser, on peut maintenant traiter par le sein fluoro-uracile, comme POMAD, ainsi de suite. Mais retenez que le cancer invasif de la vulve doit être traité par une vulvectomie totale. Lorsque je dis totale, c'est les deux lèvres, les quatre lèvres, les grandes et les petites lèvres avec le clitoris.

Tout ça, vous devez l'enlever. Et vous allez faire un curage ganglionnaire superficiel et profond et plus ou moins une radiothérapie. Pour les lésions précancéreuses ou les cancers intra-épithéliaux, le traitement doit être conservateur.

L'évolution générale, c'est un cancer qui évolue localement, exceptionnellement il entraîne des métastases, mais il peut entraîner une compression vasculaire, l'hypathie, une infection, une hémorragie, une maladie thromboembolique. La maladie thromboembolique est la première réalité des complications respiratoires, etc. Les embolies pulmonaires, oui.

Donc voilà, spontanément. En général, ce n'est pas le traitement, il y a les récidives, mais il y a le problème du traitement lui-même. La région vulvaire, c'est une région qui a une vascularisation terminale, elle a une mauvaise vascularisation, elle est à côté de l'anus, donc il s'infecte, il y a le lâchage de suture, il y a la nécrose parfois même de tissus sous-cutanés qui va entraîner une nécrose même des vaisseaux, donc il y a les complications thromboemboliques, il y a les complications liées à l'alignement.

Donc ce sont des femmes qui peuvent être hospitalisées jusqu'à 15 jours, 20 jours à l'hôpital. Donc il y a ce risque de traitement. Et bien sûr, le traitement, si vous êtes à un stade précoce, vous avez pratiquement 90% de survie à cinq ans sans problème.

Mais maintenant, on peut avoir une guérison. Voilà. La surveillance, c'est une surveillance.

En général, on ne fait rien. On doit voir les femmes, on doit examiner la cicatrise, si elle est bien cicatrisée, c'est OK. S'il y a un nodule, etc., il faut l'enlever.

S'il y a une adénopathie qui va se manifester tardivement, vous pouvez faire une cytoponction ou carrément l'enlever, comme ce que je fais. Je ne fais pas de cytoponction, je fais une petite incision et j'enlève tout le gonglion. Donc, voilà.

En général, on ne fait rien en dehors de l'examen clinique. Ça ne sert à rien de demander une TDM chaque fois que la femme va consulter. Vous demandez la TDM lorsque vous avez quelque chose à l'examen clinique.

Voilà. Merci.